

Testículo Agudo

Introducción al Testículo Agudo

El **testículo agudo** (o escroto agudo) es una de las emergencias quirúrgicas más críticas en urología. Se define como un cuadro de dolor testicular de inicio brusco, que puede acompañarse de signos inflamatorios locales.

El reconocimiento precoz es vital: la **torsión testicular** no diagnosticada ni tratada a tiempo se considera habitualmente una **negligencia médica**, debido a que el retraso en la intervención conduce inevitablemente a la pérdida del órgano por isquemia y necrosis.

Etiología y Diferenciales

Existen diversas causas de testículo agudo, pero dos destacan por su importancia clínica y frecuencia:

- **Torsión Testicular:** Es la causa más grave. Se produce por la rotación del **cordón espermático**, lo que interrumpe el flujo sanguíneo (primero venoso y luego arterial) hacia el testículo. Es la causa más frecuente en **adolescentes y adultos jóvenes**.
- **Torsión de la Hidátide de Morgagni:** La hidátide es un resto embrionario (apéndice testicular) que puede torcerse. Aunque es muy dolorosa, no pone en riesgo la viabilidad del testículo. Es la causa más frecuente de testículo agudo en **niños pequeños**.
- **Otras causas:**
  - *Infarto de un tumor testicular.*
  - **Orquiepididimitis** (generalmente de inicio subagudo, no tan brusco).
  - *Traumatismo escrotal.*

NOTA CLÍNICA

**Fisiopatología:** En la torsión testicular, el testículo gira sobre su eje dentro de la túnica vaginal (torsión intravaginal) o junto con ella (torsión extravaginal, típica en neonatos). Esto genera una obstrucción del retorno venoso, edema, compromiso arterial y finalmente necrosis isquémica.

TABLA 3.10.1: CARACTERÍSTICA VS TORSIÓN TESTICULAR

| CARACTERÍSTICA       | TORSIÓN TESTICULAR                    | TORSIÓN DE HIDÁTIDE          |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Edad típica          | Adolescentes / Adultos                | Niños prepúberes             |
| Inicio               | Brusco, muy intenso                   | Agudo, localizado            |
| Reflejo cremastérico | Ausente                               | Presente                     |
| Signo característico | Testículo ascendido / horizontalizado | "Punto azul" (Blue dot sign) |
| Riesgo de necrosis   | Muy alto (Emergencia)                 | Nulo para el testículo       |

Clínica del Testículo Agudo

La sospecha debe ser inmediata ante los siguientes hallazgos:

- **Dolor testicular:** De inicio súbito. Es importante notar que el dolor puede irradiarse o incluso presentarse primariamente como **dolor inguinal**.
- **Aumento de volumen:** Edema y eritema escrotal (no siempre presente en etapas iniciales).
- **Posición del testículo:** El testículo afectado suele estar **ascendido** (debido al acortamiento del cordón por la torsión) o en una posición horizontalizada (Signo de Angel).
- **Síntomas vegetativos:** Es frecuente que el paciente presente náuseas y vómitos debido a la intensidad del dolor.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

**Diagnóstico Diferencial:** El dolor de la torsión testicular puede confundirse con un **cólico renal**, ya que ambos pueden irradiarse hacia el flanco, zona lumbar y genitales. Sin embargo, en el cólico renal el examen físico testicular es normal.

Diagnóstico y Conducta

El diagnóstico del testículo agudo es **absolutamente clínico**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

**¡No demore la cirugía!** Nunca se debe retrasar la exploración quirúrgica para solicitar exámenes complementarios (como el Eco-Doppler testicular) si la sospecha clínica es alta. Cada minuto cuenta para salvar el testículo.

¿Cuándo pedir un Eco-Doppler?

Solo se justifica en casos de **duda diagnóstica razonable** (por ejemplo, un cuadro de varios días de evolución donde se sospecha más una orquiepididimitis) y siempre que no retrase el manejo definitivo. Un Doppler normal **no descarta** con un 100% de certeza una torsión intermitente o inicial.

Manejo Quirúrgico

La conducta estándar ante la sospecha de torsión es la **exploración quirúrgica inmediata**.

- **Exploración:** Se accede al escroto para confirmar la torsión.
- **Distorsión:** Se deshace el giro del cordón.
- **Evaluación de viabilidad:** Se observa si el testículo recupera coloración. El límite crítico son **6 horas**; después de este tiempo, el riesgo de necrosis aumenta exponencialmente.
- **Orquidopexia:** Si el testículo es viable, se fija al escroto para evitar que se vuelva a torcer.
- **Importante:** Se debe realizar **orquidopexia bilateral**, ya que el defecto anatómico que permite la torsión suele ser bilateral.
- **Orquiectomía:** Si el testículo está francamente necrótico, se debe extirpar para evitar infecciones y la formación de anticuerpos antiespermáticos que podrían dañar el testículo contralateral.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En caso de orquiectomía, se recomienda la implantación de una **prótesis testicular de silicona** para mitigar el impacto psicológico del paciente.

Análisis de Casos Clínicos

Caso 1: El "Punto Azul"

Niño de 5 años, dolor escrotal de 12 horas. Al examen: punto azul doloroso en el polo superior del testículo. - **Diagnóstico:** Torsión de la hidátide de Morgagni. - **Conducta:** Aunque el punto azul es orientador, si existe cualquier duda de viabilidad o si el cuadro es muy agudo, la exploración quirúrgica sigue siendo el estándar para descartar torsión testicular. Si se confirma hidátide en cirugía, simplemente se extirpa el resto necrótico.

Caso 2: El adolescente clásico

17 años, dolor escrotal de 2 horas, vómitos y testículo aumentado de volumen. - **Diagnóstico:** Torsión testicular hasta que se demuestre lo contrario. - **Conducta:** Exploración quirúrgica inmediata, distorsión y orquidopexia bilateral.

**Caso 3: Torsión en testículo no descendido**

Niño de 2 años, dolor inguinal de 2 horas. Se palpa testículo en el conducto inguinal. - **Escenario:** Puede ser una **Criptorquidia** no diagnosticada que se torció o un testículo que ascendió bruscamente por la torsión. - **Conducta:** Exploración quirúrgica de urgencia. Los testículos criptorquídicos tienen un riesgo significativamente mayor de torsión y tumores.

**Resumen para el EUNACOM**

- **Tiempo es tejido:** El pronóstico depende directamente de las horas de evolución (idealmente < 6 horas).
- **Clínica manda:** El diagnóstico es clínico. El Doppler es secundario.
- **Cirugía:** Siempre es exploración + orquidopexia bilateral (si es viable).
- **Reflejo cremastérico:** Suele estar abolido en la torsión testicular (útil para diferenciar de orquiepididimitis donde suele estar presente).

**CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM****ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Adolescente de dieciséis años consulta a urgencias por dolor escrotal izquierdo de inicio súbito hace dos horas, asociado a un episodio de vómito. Al examen físico el testículo izquierdo está aumentado de volumen y ascendido respecto al derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

**EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:**

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Testículo Agudo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- La torsión testicular es la causa más importante del testículo agudo en adultos y adolescentes; la torsión de hidátide de Morgagni es la más frecuente en niños pequeños
- El diagnóstico de testículo agudo es absolutamente clínico; la conducta es exploración quirúrgica inmediata sin esperar estudios de imagen
- No se debe pedir ecodoppler testicular porque cada minuto de demora es tiempo perdido para la cirugía y puede significar la pérdida del testículo
- El punto azul en el polo superior del testículo orienta a torsión de hidátide de Morgagni, pero igualmente se indica exploración quirúrgica porque no descarta torsión testicular
- Si el testículo está viable en la exploración quirúrgica se realiza destorsión más orquidopexia bilateral, porque la torsión de un lado aumenta el riesgo del contralateral
- Si el testículo está necrótico después de seis horas de evolución se realiza orquiectomía; se puede ofrecer prótesis de silicona para reducir el impacto psicológico
- El dolor testicular agudo se puede irradiar hacia el flanco y la zona lumbar, lo que puede confundirse con un cólico renal; el dolor del cólico renal también puede irradiarse hacia los genitales

## EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TESTÍCULO AGUDO)

## PREGUNTA 1

Adolescente de dieciséis años consulta a urgencias por dolor escrotal izquierdo de inicio súbito hace dos horas, asociado a un episodio de vómito. Al examen físico el testículo izquierdo está aumentado de volumen y ascendido respecto al derecho. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Solicitar ecodoppler testicular urgente para confirmar la ausencia de flujo antes de operar
- B) Exploración quirúrgica inmediata sin esperar estudios de imagen
- C) Administrar analgesia y observar cuatro horas para ver si mejora espontáneamente
- D) Solicitar sedimento de orina y urocultivo para descartar orquiepididimitis antes de decidir cirugía
- E) Derivar a urología para evaluación en las próximas veinticuatro horas

## PREGUNTA 2

Niño de cinco años con dolor escrotal derecho de doce horas de evolución. Al examen físico se observa un punto azulado en el polo superior del testículo derecho. El testículo se palpa normal en tamaño. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Observación y analgesia porque el punto azul confirma torsión de hidátide de Morgagni que no requiere cirugía
- B) Solicitar ecodoppler para confirmar que el testículo tiene flujo antes de decidir si operar
- C) Exploración quirúrgica inmediata porque no se puede descartar torsión testicular clínicamente
- D) Antibioterapia empírica por doce horas mientras se espera el resultado del hemocultivo
- E) Control en veinticuatro horas porque el punto azul indica que la causa es benigna

## PREGUNTA 3

En la exploración quirúrgica de un adolescente de diecisiete años con torsión testicular de cuatro horas de evolución, se confirma que el testículo izquierdo está viable después de la destorsión. ¿Cuál es la cirugía más completa que debe realizarse?

- A) Solo destorsión del testículo izquierdo y cierre quirúrgico
- B) Destorsión del testículo izquierdo más orquidopexia unilateral del testículo izquierdo
- C) Destorsión más orquidopexia bilateral de ambos testículos
- D) Orquitectomía del testículo izquierdo y prótesis de silicona contralateral
- E) Destorsión del testículo izquierdo y ecodoppler de control del testículo derecho

## RESUMEN: TESTÍCULO AGUDO

El testículo agudo es un síndrome clínico de urgencia urológica caracterizado por dolor testicular de inicio agudo que puede ser la manifestación de varias causas, siendo las dos más importantes la torsión testicular y la torsión de la hidátide de Morgagni. La torsión testicular es la causa más frecuente en adultos y adolescentes y produce torsión del cordón espermático completo, con riesgo de necrosis testicular si no se trata dentro de las seis horas. La torsión de la hidátide de Morgagni, un resto embrionario, es la causa más frecuente en niños pequeños y tiene mejor pronóstico dado que no compromete el testículo propiamente tal. La clínica del síndrome de testículo agudo es dolor testicular o inguinal de inicio súbito, a veces con aumento de volumen del testículo y en ocasiones el testículo se encuentra ascendido en el canal inguinal. El diagnóstico del testículo agudo es absolutamente clínico y la conducta es siempre la exploración quirúrgica inmediata, sin demoras para realizar estudios adicionales. No se pide ecodoppler testicular porque el tiempo que tarda en realizarse e interpretarse son minutos preciosos perdidos para la cirugía, y el ecodoppler no es más sensible ni más específico que la exploración quirúrgica para confirmar o descartar la torsión. Si en la exploración quirúrgica el testículo está viable se realiza destorsión más orquidopexia bilateral, dado que la torsión de un testículo aumenta el riesgo de torsión del contralateral. Si el testículo ya está necrótico, generalmente después de seis horas, se realiza orquitectomía y se puede ofrecer una prótesis de silicona para minimizar el impacto psicológico. El punto azul es un hallazgo clínico que sugiere torsión de hidátide de Morgagni: se ve a través de la piel del escroto como un punto oscuro o azulado en el polo superior del testículo, que corresponde a la hidátide necrótica. Sin embargo, incluso cuando se sospecha torsión de hidátide, la conducta sigue siendo la exploración quirúrgica inmediata porque no se puede descartar clínicamente una torsión testicular que amerite cirugía de destorsión.